

Guia de Manejo de Hipertension Arterial

Documento educativo para el proyecto MedAssistant - dev/talles

Este documento fue creado exclusivamente con fines educativos para demostrar la funcionalidad de Retrieval-Augmented Generation (RAG) en el curso de Spring AI. No constituye asesoramiento medico profesional. Ante cualquier duda sobre su salud, consulte a un profesional de la salud calificado.

1. Definicion y Clasificacion

La hipertension arterial se define como una presion arterial sistolica igual o superior a 140 mmHg o una presion arterial diastolica igual o superior a 90 mmHg, medida en al menos dos ocasiones diferentes en condiciones adecuadas de reposo. Es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, incluyendo infarto agudo de miocardio y ataque cerebrovascular.

La clasificacion de la presion arterial en adultos es la siguiente: presion normal cuando es menor a 120/80 mmHg; presion elevada cuando la sistolica esta entre 120 y 129 mmHg con diastolica menor a 80 mmHg; hipertension grado 1 cuando la sistolica esta entre 130 y 139 mmHg o la diastolica entre 80 y 89 mmHg; e hipertension grado 2 cuando la sistolica es igual o mayor a 140 mmHg o la diastolica igual o mayor a 90 mmHg.

2. Factores de Riesgo Conductuales

Los cuatro principales factores de riesgo conductuales para la aparicion de enfermedades cardiovasculares son: alimentacion poco saludable, actividad fisica insuficiente, consumo de tabaco y consumo nocivo de alcohol. Estos factores son modificables y su control adecuado puede reducir significativamente el riesgo cardiovascular.

La alimentacion poco saludable se caracteriza por un consumo excesivo de sodio (sal), grasas saturadas, grasas trans y azucares libres, junto con un consumo insuficiente de frutas, verduras y fibra. Una dieta alta en sodio contribuye directamente al aumento de la presion arterial. Se recomienda limitar el consumo de sal a menos de 5 gramos por dia, equivalente a aproximadamente una cucharadita.

La inactividad fisica es uno de los principales factores de riesgo de muerte prematura a nivel mundial. Las personas que no realizan actividad fisica suficiente tienen entre un 20 y un 30 por ciento mas de probabilidades de morir prematuramente que aquellas que la realizan de manera regular.

3. Recomendaciones de Actividad Fisica

Para adultos, se recomienda realizar al menos 150 minutos de actividad fisica moderada a la semana, o al menos 75 minutos de actividad fisica vigorosa, o una combinacion equivalente de

ambas. La actividad moderada incluye caminar a paso ligero, subir escaleras, bailar, realizar tareas de jardinería o domésticas. La actividad vigorosa incluye correr, montar en bicicleta a ritmo rápido, nadar o practicar deportes competitivos.

La práctica regular de actividad física ayuda a reducir el riesgo de hipertensión, infarto agudo de miocardio, ataque cerebrovascular, diabetes y varios tipos de cáncer. También contribuye al control del peso corporal, mejora los valores de presión arterial y los niveles de colesterol en sangre. Realizar alguna actividad física es siempre mejor que no hacer ninguna, y las personas inactivas pueden comenzar con sesiones cortas de 10 minutos e incrementar gradualmente.

4. Tratamiento Farmacológico

El tratamiento farmacológico de primera línea para la hipertensión incluye cuatro grupos de medicamentos: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) como enalapril y lisinopril; bloqueadores de los receptores de angiotensina (ARA II) como losartan y valsartan; bloqueadores de canales de calcio como amlodipino; y diuréticos tiazídicos como hidroclorotiazida.

En pacientes diabéticos se prefieren los inhibidores de la ECA o los ARA II por su efecto nefroprotector. En pacientes con enfermedad coronaria, los betabloqueantes pueden ser de primera elección. En mujeres embarazadas, los inhibidores de la ECA y los ARA II están contraindicados por sus efectos teratogénicos.

La meta terapéutica general es mantener la presión arterial por debajo de 130/80 mmHg en la mayoría de los pacientes. En adultos mayores de 65 años, el objetivo puede ser menos estricto según la tolerancia individual del paciente y la presencia de comorbilidades.

5. Interacciones con Antiinflamatorios

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como el ibuprofeno pueden interferir con el tratamiento antihipertensivo. El ibuprofeno puede reducir el efecto de los inhibidores de la ECA, los ARA II y los diuréticos, provocando un aumento de la presión arterial. En pacientes hipertensos que necesitan analgesia, se recomienda utilizar paracetamol como alternativa cuando sea posible, o monitorear la presión arterial con mayor frecuencia si se utiliza ibuprofeno.

El uso combinado de ibuprofeno con anticoagulantes como warfarina aumenta significativamente el riesgo de sangrado gastrointestinal. No se recomienda el uso simultáneo de ibuprofeno con otros AINEs ni con aspirina en dosis antiinflamatorias.

6. Modificaciones del Estilo de Vida

Las modificaciones del estilo de vida son fundamentales tanto para la prevención como para el tratamiento de la hipertensión arterial. Estas incluyen: reducción del consumo de sodio a menos

de 5 gramos diarios; aumento del consumo de frutas y verduras a al menos 5 porciones diarias; realizacion de al menos 150 minutos semanales de actividad fisica moderada; mantenimiento de un peso corporal saludable; moderacion en el consumo de alcohol limitandolo a maximo 2 unidades por dia en hombres y 1 unidad en mujeres; y cesacion completa del consumo de tabaco.

Dejar de fumar es la intervencion individual mas importante que un fumador puede realizar para mejorar su salud cardiovascular. Despues de un anio sin fumar, el riesgo de infarto agudo de miocardio se reduce aproximadamente a la mitad. Despues de 15 anios, el riesgo cardiovascular es similar al de una persona que nunca fumo.